

行動経済学で支えるメンタルヘルス診療

ナッジ・インセンティブ・コミットメントデバイス — 説教から設計へ

出典（主）



このセッションで持ち帰ってもらう 3 つ

1. 「分かっているけどやめられない」を 脳の報酬処理の問題 として説明できる
2. ナッジ / インセンティブ / コミットメントデバイス の 使い分けの軸 を持つ
3. 自分の外来導線を 行動設計の対象 として眺められる視点

約束： 今日の話は、明日の外来で 1 人の患者にかけer一言から始まります。

後半に進むにつれて、外来の壁紙やリマインダー文言まで話が広がりますが、置いていきません。

0. なぜ今この話？

- 2025 年、米国の主要レビュー論文が「メンタルヘルスへの行動経済学・神経経済学の応用」を整理
- うつ病・依存症・不安症は、それぞれ別物のように語られてきた
- でも 報酬処理の障害 という共通の機能不全がある (=transdiagnostic)
- ペンシルベニア大学医学部には Penn Medicine Nudge Unit という世界初の医療機関組み込み型行動設計チームがある
- 「説教」では行動は変わらない、というのは我々が薄々知っていたこと。それを 科学が裏打ち してくれた
- 出典 : Applications of Behavioral Economics and Neuroeconomics in Mental Health, *PMC11904746*, 2025

Part 1. 症例から入る

症例：38 歳女性、うつ病、抗うつ薬治療中

この人は、怠けているのか？
30 秒、隣の人と話してみてください。

- ・ 大うつ病性障害、SSRI 内服中、半年経過
- ・ 「最近どうですか？」→「変わらないです……」
- ・ 「お薬は飲めてますか？」→「……たまに忘れます」
- ・ 「散歩、続けてますか？」→「先生が言ってたから、やろうと思ってるんですけど……」
- ・ 「ジムの体験予約、行けました？」→「ネットで予約まではしたんですけど、当日になると……」

「分かっているけどやめられない / 始められない」の正体

「やるべきだと分かっている」と「実際にやる」の間には、巨大な溝がある。
そして、うつ病・依存症・不安症の患者ではその溝が脳機能レベルで深くなっている。
これは「意志の弱さ」ではない。脳の演算が違う。

- ・ 腹側線条体・前頭前野 — 報酬回路の中心
- ・ 「将来の報酬」を小さく見積もるバイアス（双曲割引）が強い
- ・ 将来の散歩の気分の良さ < 今ベッドにいる安心感

"怠惰"ではなく"報酬処理の連続体"

病名	共通する報酬処理の特徴
うつ病	報酬への期待感の低下、努力に対する報酬感度の低下
依存症	即時報酬への過大評価、長期コストの過小評価
不安症	将来の損失への過剰な重み付け、回避行動の強化

違う病名のように見えるが、腹側線条体と前頭前野の同じ回路の異なる現れ方。
RDoC(米国 NIMH の研究領域分類)でも Positive Valence Systems としてまとめられている。

Part 2. 概念整理 — 3つの介入

介入 1: ナッジ (Nudge)

特徴：コスト低い、抵抗感少ない、効果は穏やか～中等度

- 選択肢を変えずに、選びやすさを変える
- 強制ではない。インセンティブも与えない。設計だけを変える
- 例：学校給食で野菜を目線の高さに置くと摂取量が増える
- 医療例：処方箋のデフォルトをジェネリックにすると後発薬使用率が上がる

介入 2: インセンティブ (Incentive)

特徴：効果は強い、ただしコスト・倫理的配慮・終了後の reversion(逆戻り) に注意

- 行動した本人に報酬を与える (金銭・ポイント・特典)
- 例：禁煙プログラムで 1 か月禁煙できたら \$100 給付
- 神経経済学的根拠：即時報酬で双曲割引のバイアスを逆手に取る

介入 3: コミットメントデバイス (Commitment Device)

特徴： 本人の意志に基づくのでパターナリズムの問題が小さい、設計の手間がある

- 未来の自分を縛る仕組みを、現在の自分に作らせる
- 例： 「3 か月後に体重が減らなかったら \$200 寄付」と公言してウェブで管理
- 例： 病院予約を " 自動再予約 " にする (キャンセルにアクションが要る)
- 神経経済学的根拠： 「合理的な現在の自分」と「弱い未来の自分」を分離する

3 つを使い分けるデシジョンツリー

Q1. 患者本人が「変えたい」と言っている？

- └ NO → ナッジから（本人の合意がいない）
- └ YES → Q2 へ

Q2. 自制心のサポートが必要そう？

- └ NO → インセンティブ（短期決戦）
- └ YES → コミットメントデバイス（本人主導の縛り）

もちろん組み合わせ OK。

「ナッジで導線を整え、コミットメントデバイスで本人を縛る」は最強パターン。

さっきの症例に当てはめると

介入	この症例での実装案
ナッジ	服薬管理アプリのリマインダー時刻を「夕食の時間」にデフォルト設定。散歩は「玄関に靴を出しておく」だけのワーク
インセンティブ	「次回までに散歩を 5 回できたら、自分で何か小さな褒美を決めておく」と一緒に決める
コミットメントデバイス	「次回外来日を今ここで一緒に予約する。私と看護師さんで覚えておく」 = スケジュールの外部化

Part 3. 自分の診療への適用

明日の外来で 1 つだけ試せること

☒ 説教モード	☒ 設計モード
「散歩、続けてくださいね」	「次の散歩の前に何を準備しておいたら一番楽になりそうですか？」
「お薬、ちゃんと飲んでくださいね」	「飲み忘れる時って、どんな時ですか？ その時間帯のリマインダー、一緒に決めましょう」
「禁煙、頑張ってくださいね」	「次に吸いたくなったら、その代わりに 3 分だけ別のことをするとしたら、何をしたいですか？」

説教モードの一言を、設計モードの一言に置き換えてみる：

言葉のフレーミングを変える

「やってないんですね」 → 「今は、それをやるエネルギーが必要な状態じゃないんですね」
これは責任を回避する言い方ではない。

「怠惰」フレームから「報酬処理」フレームへの言い換え で、患者は自分を責めずに次の一步を考えやすくなる。

報酬処理障害は 脳の状態 であって、人格ではない。これは患者にも伝えていい。

自分の外来でのふりかえり (30 秒)

外来終わりに 30 秒、こう問う :

1. 今日、説教モードに流されかけた瞬間 はなかったか？
 2. その時、設計モードならどう声をかけられたか？
 3. 患者の生活の中の " 次の一步のハードル " は、どこに下げられそうか？
- メモは要らない。考える習慣だけでいい。

Part 4. 次の半径へ — 外来導線という " 見えないナッジ "

あなたの外来は、すでにナッジ設計されている（良くも悪くも）

「どうデザインするか」を意識しないとき、それは " たまたまそうになっているデザイン " になっている。
ナッジ設計とは、その " たまたま " を 意図的に することにすぎない。

- ・ 待合室の椅子の配置 → 患者同士の距離感
- ・ 問診票の質問順 → 何を最初に話してもらうか
- ・ 検査結果の表示順 → 何に注目させるか
- ・ 予約システムのデフォルト → 通院頻度を決めている

外来導線で「ちょっと触る」レベルの工夫

どれも今日明日で全部やる必要はない。

「これは自分が将来触れる場所だ」と思って外来を歩くと、見え方が変わる。

- ・ 受付の問診票に「今日一番話したいこと」を1行書ける欄を追加
- ・ 電子カルテのテンプレに「次回までの宿題」欄を作る（処方→学習への自分用ナッジ）
- ・ 検査結果説明で「数値」を見せる前に「前回からの間に何がありましたか？」を聞く順番に
- ・ 待合のポスターを「禁煙してください」から「次に吸いたくなかった時のための作戦を1つ持っていますか？」に変える

Part 5. 自院・地域に持ち帰る ― 診療デザイナーとしての医師

Penn Medicine Nudge Unit という存在

重要なのは「医療機関の中に行動設計チームが組み込まれている」という事実そのもの。
「医療は科学だが、その科学を 誰かに届ける ところは設計の問題」、と組織が宣言している。

- ・ ペンシルベニア大学医学部に常駐する、行動経済学者・心理学者・医師混成のチーム
- ・ 院内のあらゆる導線を「行動設計の対象」として捉え、実証実験を回している
- ・ 例：処方デフォルト変更で後発薬使用率が劇的に上がった、ワクチン接種リマインダー文言を変えたら接種率が上がった、など多数の論文

我々がそこから持ち帰れるもの

すぐに Nudge Unit を作れなくても：

医師は治療者であると同時に、患者の生活と医療システムを繋ぐ " 設計者 " でもある。
この役割は、訓練すれば誰でも身につけられる。

- ・ 「うちの外来のここが患者の選択を歪めている」を 1 つ言語化してみる
- ・ 多職種カンファで「行動設計の話」を 1 スライド入れてみる
- ・ 「説教ではなく設計」という共通言語を、看護師・薬剤師・MSW と共有してみる

マクロ予測

論文と Conductor の予測：

家庭医療・総合診療は、患者の生活全体を見ているという点で、この分野の 相性が極めて良い 専門職。

- 2026 ～ 2028 年に EMR 組み込み型ナッジ の議論が日本でも始まる
- 時間的割引率の簡易測定 が依存症スクリーニングの補助指標として普及し始める
- 家庭医がナッジ設計チームのコアメンバーとして位置付けられる動きも加速する見通し

今日のまとめ

1. 「分かっているけどやめられない」は報酬処理の脳機能の話（怠惰ではない）
2. ナッジ / インセンティブ / コミットメントデバイスの3つの介入があり、使い分けの軸がある
3. 明日の外来で説教モード→設計モードの一言に置き換えられる
4. 半径を広げると、外来導線・院内全体が行動設計の対象に見えてくる
5. 医師は治療者であると同時に診療デザイナーという役割を持てる

明日からの宿題（任意）

うまくいかなくても OK。やってみて気づいたことを次回シェア してください。

- 1 人の患者で「設計モードの一言」を試す
- 自分の外来で「ここはたまたまそうになっているデザイン」を 1 つ見つける
- 「説教ではなく設計」という言葉をチーム内で 1 回使ってみる

出典

<<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11904746/>>
<<https://chti.upenn.edu/nudge-unit>>

- 主出典 : *Applications of Behavioral Economics and Neuroeconomics in Mental Health*. PMC11904746. 2025 年 .
- 副出典 : Penn Medicine Nudge Unit | CHTI.
- 背景文献 :
- カーネマン 『ファスト & スロー』
- セイラー & サンステイーン 『NUDGE — 実践 行動経済学』
- NIMH RDoC: Positive Valence Systems

参考：もう一步深めたい人へ

興味が湧いたら、Slack #learning にひとこと投げてください。文献紹介します。

- プロスペクト理論・損失回避・双曲割引・フレーミング効果（カーネマン）
- 神経経済学：腹側線条体・前頭前野・ドーパミン報酬予測誤差シグナル
- トランスダイアグノスティック・アプローチ：NIMH RDoC Positive Valence Systems
- リバタリアン・パターナリズム：セイラー & サンステーン

Generated by Scribe / 2026-04-09 / 出典は必ず一次資料を確認してください

出典（主）

